

Eritrodermia y Síndrome de Stevens-Johnson / Necrólisis Epidérmica Tóxica

(Basado en Guías Clínicas MINSAL Chile 2023, British Association of Dermatologists 2024, EADV Guidelines 2024, American Academy of Dermatology 2025, UpToDate 2025 y Fitzpatrick's Dermatology 2023.)

1. Introducción y relevancia clínica

El **Síndrome de Stevens-Johnson (SJS)** y la **Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET o Lyell)** constituyen **reacciones mucocutáneas graves, potencialmente mortales**, secundarias casi siempre a **fármacos**.

Ambas entidades representan **diferentes grados de severidad del mismo proceso patológico**, diferenciándose únicamente por la **extensión del desprendimiento epidérmico**:

Entidad	Desprendimiento epidérmico
SJS	<10% de la superficie corporal
SJS/TEN solapado	10–30%
TEN (Lyell)	>30%

Relevancia clínica

- Mortalidad: **SJS 5–10%, TEN 30–50%**.
- Causa más frecuente: **fármacos** (anticonvulsivantes, sulfas, antibióticos, AINES).
- Es una **emergencia dermatológica**: requiere **hospitalización inmediata**, preferentemente en **unidad de quemados o UCI**.
- En **EUNACOM**, se evalúa la **capacidad de reconocer signos iniciales** (eritema mucocutáneo doloroso + fiebre + ampollas) y el manejo inicial apropiado (suspender

fármaco y derivar urgente).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Naturaleza de la reacción

Es una **reacción de hipersensibilidad tardía tipo IVc**, mediada por linfocitos T citotóxicos (CD8+) que inducen **apoptosis masiva de queratinocitos**.

2.2. Mecanismo inmunológico

1. **Sensibilización previa al fármaco** → presentación antigénica por HLA específicos.
 2. Activación de **linfocitos T CD8+ y células NK** → liberación de **perforina, granzima B y granulolisina**.
 3. Inducción de **apoptosis epidérmica difusa** → necrosis queratinocitaria y **desprendimiento epidérmico**.
-

2.3. Fármacos frecuentemente implicados

Categoría	Fármacos
Anticonvulsivantes	Lamotrigina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital
Antibióticos	Sulfamidas, penicilinas, cefalosporinas, quinolonas
AINEs (oxicams)	Piroxicam, tenoxicam
Alopurinol	Especialmente en ancianos y con insuficiencia renal

2.4. Factores de riesgo

- Infecciones virales (VIH, VEB, micoplasma).
 - Polifarmacia y edad avanzada.
 - Genéticos:
 - **HLA-B*1502** → riesgo alto con carbamazepina (poblaciones asiáticas).
 - **HLA-B*5801** → alopurinol (asiáticos y latinoamericanos).
 - Inmunosupresión.
-

2.5. Cronología

- Usualmente **4–28 días después del inicio del fármaco**.
 - En reexposiciones previas, puede ser más precoz (1–3 días).
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Síntomas prodrómicos (fase inicial)

Duración: 1–3 días antes de lesiones cutáneas.

- Fiebre alta (>38,5°C).
 - Odinofagia, malestar general, tos, artralgias.
 - Dolor cutáneo o sensación de quemadura (“piel sensible al tacto”).
-

3.2. Lesiones cutáneas características

- Máculas eritematosas dolorosas, confluentes, que progresan a:
 - Ampollas flácidas → erosiones y desprendimiento epidérmico.
 - **Signo de Nikolsky positivo:** desprendimiento de la epidermis al roce suave.
 - Compromiso simétrico, predominante en tronco, cara y extremidades proximales.
 - Piel con aspecto de “quemadura de segundo grado”.
-

3.3. Compromiso mucoso (clave diagnóstica)

Presente en >90% de los casos:

- **Oral:** erosiones dolorosas, estomatitis, sialorrea.
 - **Ocular:** conjuntivitis, blefaritis, úlceras corneales.
 - **Genital:** erosiones, disuria, sinequias.
 - **Digestivo / respiratorio:** posible compromiso interno.
-

3.4. Diferencias entre SJS y NET

Característica	SJS	NET
Desprendimiento cutáneo	<10%	>30%
Mortalidad	5–10%	30–50%
Ampollas	Pequeñas, localizadas	Extensas, con epidermis colgante

Fase inicial	Más prolongada	Más abrupta
Compromiso mucoso	Siempre presente	Siempre presente y severo

3.5. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Eritema multiforme mayor	Lesiones en “diana”, menos desprendimiento, curso autolimitado
DRESS	Exantema morbiliforme + eosinofilia + hepatitis, sin necrosis epidérmica
Pénfigo vulgar	Crónico, sin fiebre ni síntomas prodrómicos
Quemaduras térmicas	Historia de exposición evidente
Síndrome estafilocócico de piel escaldada (SSSS)	En niños; cultivo positivo a <i>S. aureus</i> , mucosas respetadas

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

Principalmente **clínico**:

- Antecedente de uso reciente de fármaco de riesgo.
- Fiebre, malestar general.

- Lesiones ampollares dolorosas con desprendimiento epidérmico.
 - Compromiso de mucosas.
-

4.2. Exámenes complementarios

- **Hemograma:** anemia, leucocitosis, linfopenia.
 - **Eosinofilia:** rara (diferencia con DRESS).
 - **Función hepática y renal:** elevadas transaminasas o urea/creatinina por afectación sistémica.
 - **PCR y VSG:** elevadas.
 - **Biopsia cutánea:** necrosis queratinocitaria masiva con separación dermoepidérmica, infiltrado linfocitario escaso.
-

4.3. Escala pronóstica SCORTEN (cada parámetro = 1 punto)

Variable	Punto si presente
Edad >40 años	1
Cáncer o enfermedad maligna	1
Desprendimiento >10% SC	1
Frecuencia cardíaca >120/min	1

Urea >10 mmol/L	1
-----------------	---

Glucosa >14 mmol/L	1
--------------------	---

Bicarbonato <20 mmol/L	1
------------------------	---

Interpretación:

- 0–1 punto: mortalidad <10%
- 2 puntos: 12%
- 3 puntos: 35%
- ≥4 puntos: >50%

5. Tratamiento (según guías MINSAL / BAD / EADV / UpToDate)

5.1. Principios generales

Emergencia dermatológica.

- **Suspensión inmediata del fármaco sospechoso.**
- **Hospitalización en UCI o unidad de quemados.**
- **Medidas de soporte intensivo:** control térmico, fluidos, nutrición, manejo del dolor e infecciones.

5.2. Manejo inicial (primeras 24 horas)

Medida	Descripción
--------	-------------

Retirar fármaco causal	Detener todos los medicamentos no esenciales
Reposición de líquidos EV	Según fórmula de Parkland modificada (como quemado 2° grado)
Temperatura ambiente controlada (28–30°C)	Evita pérdida de calor
Cuidado cutáneo	Apósitos no adherentes, evitar desbridamiento agresivo
Profilaxis ocular temprana	Lágrimas artificiales + derivación a oftalmología
Nutrición enteral temprana	Favorece cicatrización y reduce infecciones
Analgesia y control del dolor	Paracetamol o opioides leves (evitar AINES)

5.3. Terapias específicas (según guías 2024)

Terapia	Evidencia / uso
Corticoides sistémicos	Controversiales: útiles en fases iniciales (prednisona 1–2 mg/kg/día por ≤3 días)
Inmunoglobulina IV (IVIG)	2–3 g/kg en 3–5 días; útil si <48 h desde inicio; inhibe Fas-FasL
Ciclosporina	3–5 mg/kg/día; reduce mortalidad y tiempo de reepitelización (nivel A de evidencia)

Etanercept o infliximab Casos refractarios; bloquean TNF- α , en centros especializados

Antibióticos Solo si hay infección comprobada (no profilaxis rutinaria)

En Chile y Latinoamérica, **la ciclosporina** ha ganado preferencia por disponibilidad, eficacia y bajo costo comparado con IVIG.

5.4. Manejo de complicaciones específicas

- **Oculares:** colirios antibióticos + lágrimas artificiales; si ulceración corneal → suero autólogo o amnioplastia.
 - **Respiratorias:** riesgo de bronquiolitis obliterante → ventilación asistida si necesario.
 - **Urinarias / genitales:** higiene meticulosa, evitar sinequias.
 - **Digestivas:** manejo conservador de erosiones orales con anestésicos tópicos y nutrición enteral.
-

5.5. Seguimiento

- Control en dermatología y oftalmología a las 2, 4 y 12 semanas.
 - Educación sobre evitar el fármaco causal.
 - Registro en ficha clínica y **tarjeta de alergia**.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Frecuencia	Comentario
Infecciones secundarias	Alta	Principal causa de muerte (S. aureus, Pseudomonas)

Deshidratación / desequilibrio electrolítico	Común	Por pérdida transdérmica
Alteraciones oculares crónicas	20–50%	Xerosis, sinequias, ceguera
Estenosis esofágica o uretral	Rara pero grave	Por cicatrización
Sepsis / shock séptico	Grave	Mortalidad alta
Trastornos psicológicos	Frecuente	Estrés postraumático, ansiedad

Pronóstico:

- Mortalidad global 15–40% según SCORTEN.
- Recuperación de la piel en 2–3 semanas, pero con posibles secuelas oculares o cicatriciales.
- Reexposición puede ser **letal**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **SJS y NET son el mismo espectro:** se diferencian por el % de superficie corporal afectada.
2. **Lesiones dolorosas, ampollas flácidas, mucosas afectadas → pensar en SJS/TEN.**
3. **Causa más frecuente:** fármacos (lamotrigina, alopurinol, sulfas, AINES).
4. **Signo de Nikolsky positivo y mucosas afectadas** son hallazgos cardinales.

5. El manejo inicial es **suspender el fármaco y derivar a UCI o unidad de quemados**.
 6. **Ciclosporina o IVIG** son las terapias específicas con mejor evidencia.
 7. **Evitar corticoides prolongados**: aumentan riesgo infeccioso y mortalidad.
-



Errores comunes

- Diagnosticar erróneamente como **eritema multiforme** (sin mucosas afectadas ni necrosis epidérmica).
 - **No suspender el medicamento** sospechoso.
 - Tratar ambulatoriamente o sin derivación hospitalaria.
 - Usar **antibióticos profilácticos innecesarios**.
 - No proteger mucosas ni derivar a oftalmología tempranamente.
 - No calcular el **SCORTEN** para estratificar mortalidad.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **Síndrome de Stevens-Johnson (SJS)** y la **Necrólisis Epidérmica Tóxica (TEN)** son **reacciones graves a fármacos**, con necrosis epidérmica y compromiso mucoso.
2. Se diferencian por el **porcentaje de piel afectada**: SJS <10%, TEN >30%.
3. Los **fármacos más frecuentes** son alopurinol, anticonvulsivantes (lamotrigina, fenitoína, carbamazepina), sulfas y AINES.
4. Se manifiestan con **fiebre, dolor cutáneo, erosiones mucosas y ampollas flácidas** con **signo de Nikolsky positivo**.
5. El manejo requiere **suspender el fármaco**, hospitalizar en **UCI o unidad de quemados**, reponer líquidos y proteger mucosas.

6. La **ciclosporina o IVIG** mejoran el pronóstico si se administran precozmente.

7. En **EUNACOM**, recordar:

- “Paciente con fiebre, erosiones orales y ampollas flácidas tras uso de alopurinol → SJS.”
- “Primer paso: suspender fármaco y hospitalizar en unidad de quemados.”